



世界卫生组织

黄热病

2025年10月20日 | 阅读时间 7 分钟 (1878 字)

[English](#)[العربية](#)[Français](#)[Русский](#)[Español](#)

重要事实

- 黄热病是一种蚊子传播的病毒性疾病，主要由日间叮咬的蚊子传播。
- 27个非洲国家和13个拉丁美洲国家被列为黄热病暴发高风险国家。国际传播到此前未受影响地区的可能性仍然构成全球卫生安全关切。
- 只需一剂安全、负担得起的疫苗即可提供终身保护。
- 估计非洲和美洲每年发生67 000-173 000例严重感染和31 000-82 000例死亡，其中大部分负担在非洲（1， 2）。

概述

黄热病是可用疫苗预防的一种易流行疾病，由虫媒病毒引起，通过受感染的伊蚊、趋血蚊和煞蚊叮咬传播给人类。这些蚊子在室内、森林（丛林）和半室内环境中繁殖。

由于黄热病影响大且会发生国际传播，对全球卫生安全构成重大威胁。

症状

黄热病的最初症状是发烧、头痛、全身疼痛、恶心、呕吐和虚弱。这些症状通常在3-4天内消失。

大约15%的黄热病感染者会出现严重感染。症状包括反复高烧、黄疸（皮肤和眼睛变黄）、呕吐、出血（口、鼻、眼和胃）、器官衰竭和休克。约一半进入该阶段的患者在7-10天内死亡。

黄热病的潜伏期为3至6天。

治疗

目前尚无特异性抗病毒治疗方法。临床仍然以支持性护理为主。2025年临床管理指南包含规范化诊疗方法。现有两种抗病毒药物索非布韦和单克隆抗体TY014仅推荐在研究环境中使用（3）。

支持性护理包括：休息和补水；管理肝衰竭、肾衰竭和发热；用抗生素治疗继发细菌感染。患者可以根据严重程度在家中管理、住院治疗或前往急诊。黄疸是严重疾病的征兆，需要住院治疗，通常在重症监护室。

诊断

诊断具有挑战性，尤其是在临床表现无特异性的早期。严重病例可能类似于疟疾、钩端螺旋体病、病毒性肝炎以及其他出血热（例如登革热）和中毒。

诊断过程如下：

- 早期：通过逆转录聚合酶链反应检测血液；
- 后期：通过酶联免疫吸附试验或蚀斑减少中和试验进行血液抗体检测。

预防

疫苗接种

接种疫苗是预防疾病的最有效方法。单剂即可提供终生免疫，无需强化接种。80-100%的人在10天内产生免疫力，超过99%的人在30天内产生免疫力。

副作用很少见。以下人群不建议接种疫苗：

- 9个月以下的婴儿；
- 孕妇（疫情暴发期间除外）；
- 对鸡蛋严重过敏的人；
- 患有严重免疫缺陷或甲状腺疾病的个体。

对于60岁以上的人，应仔细考虑疫苗接种的风险收益比（4）。

根据《国际卫生条例》，各国可能要求旅行者提供疫苗接种证明。医疗豁免必须经过认证。

媒介控制

病媒控制需要采取以下措施：

- 消除蚊子滋生地（例如积水）；

- 在水容器中使用杀幼虫剂；以及
- 穿着防护服并使用驱虫剂。

药浸蚊帐效果较差，因为传播黄热病的蚊子在白天叮咬。

病媒监测，特别是埃及伊蚊监测，有助于评估城市疫情暴发风险。

流行病防范、监测和应对

快速检测和实验室确认以及紧急疫苗接种对于控制疫情至关重要。世卫组织估计，在疫情中，实际病例可能比报告病例数量高出10至250倍。高风险国家应至少保留一个国家实验室进行黄热病检测。必须对任何确诊病例都进行调查，并采取紧急和长期免疫接种措施。疫情暴发期间，黄热病存在向传播风险较低的国家输出的风险。加强风险意识、早期发现和应对对于预防本地传播至关重要。

世卫组织的应对

消除黄热病流行战略是一项全面长期战略，借鉴了安哥拉和刚果民主共和国城市疫情的经验教训。其目标是到2026年底结束黄热病流行。消除黄热病流行战略由全球疫苗免疫联盟、联合国儿童基金会和世卫组织指导。该伙伴关系的全球秘书处由世卫组织代管。战略由伙伴联盟制定，旨在应对黄热病不断变化的流行病学、蚊子的死灰复燃以及城市疫情和国际传播风险的增加。

它包括三个战略目标：

- 在高风险国家开展大规模疫苗接种行动，以防止疫情暴发，并定期进行儿童免疫接种和补种活动以维持成果；
- 加强城市防范并保护高风险工人；这包括加强《国际卫生条例（2005）》的实施，防止国际传播；以及
- 早期病例检测和应对，以快速遏制疫情。

参考文献

1. Gaythorpe K.A.M.等人。黄热病全球负担。《电子生命》。2021年；10:e64670。
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33722340/>
2. Garske T.等人。非洲黄热病：根据疫情和血清学数据估算疾病负担和大规模疫苗接种的影响。《公共科学图书馆·医学》。2014年；11(5):e1001638 -
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24800812/>
3. 世界卫生组织。(2025年)。世卫组织虫媒病毒疾病临床管理指南：登革热、基孔肯雅热、寨卡病毒和黄热病。世界卫生组织。<https://iris.who.int/handle/10665/381804>。
4. 世界卫生组织。(2013年)。黄热病疫苗和接种:世卫组织立场文件–2013年6月= Note de synthèse : position de l’OMS sur les vaccins et la vaccination contre la fièvre jaune, juin 2013. Weekly Epidemiological Record = Relevé épidémiologique hebdomadaire, 88 (27), 269 - 83. <https://iris.who.int/handle/10665/242089>